

21. EL LIGAMENTO DE LILIEQUIST

DURACIÓN : 07:37

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la anatomía y los mecanismos del ligamento de Liliequist, una estructura esencial que actúa como un diafragma a nivel del tercer ventrículo. Se aprende cómo este ligamento interactúa con el nervio oculomotor y el tronco basilar, influyendo así en el sistema ventricular y la hipófisis. Se abordan los conceptos de tensiones membranosas, ejes de movimiento craneal y su impacto en los sistemas facial y hormonal, al tiempo que se subraya la importancia de los movimientos cráneo-esterno-sacros y mandibulares. El análisis de las tensiones también puede ayudar a diagnosticar disfunciones a nivel oclusal, ofreciendo claves terapéuticas para restablecer la armonía corporal.

EL LIGAMENTO DE LILIEQUIST: ANATOMÍA Y MECANISMOS

El **ligamento de Liliequist** es una estructura anatómica que actúa como un pequeño diafragma, comúnmente llamado **membrana de Liliequist**. Este ligamento se inserta a nivel del **tercer ventrículo** y desciende hasta el **esfenoides**. En este punto, juega un papel crucial en relación con el **nervio oculomotor** y el paso arterial, especialmente el **tronco basilar**, que es responsable de la formación de las **arterias cerebrales**.

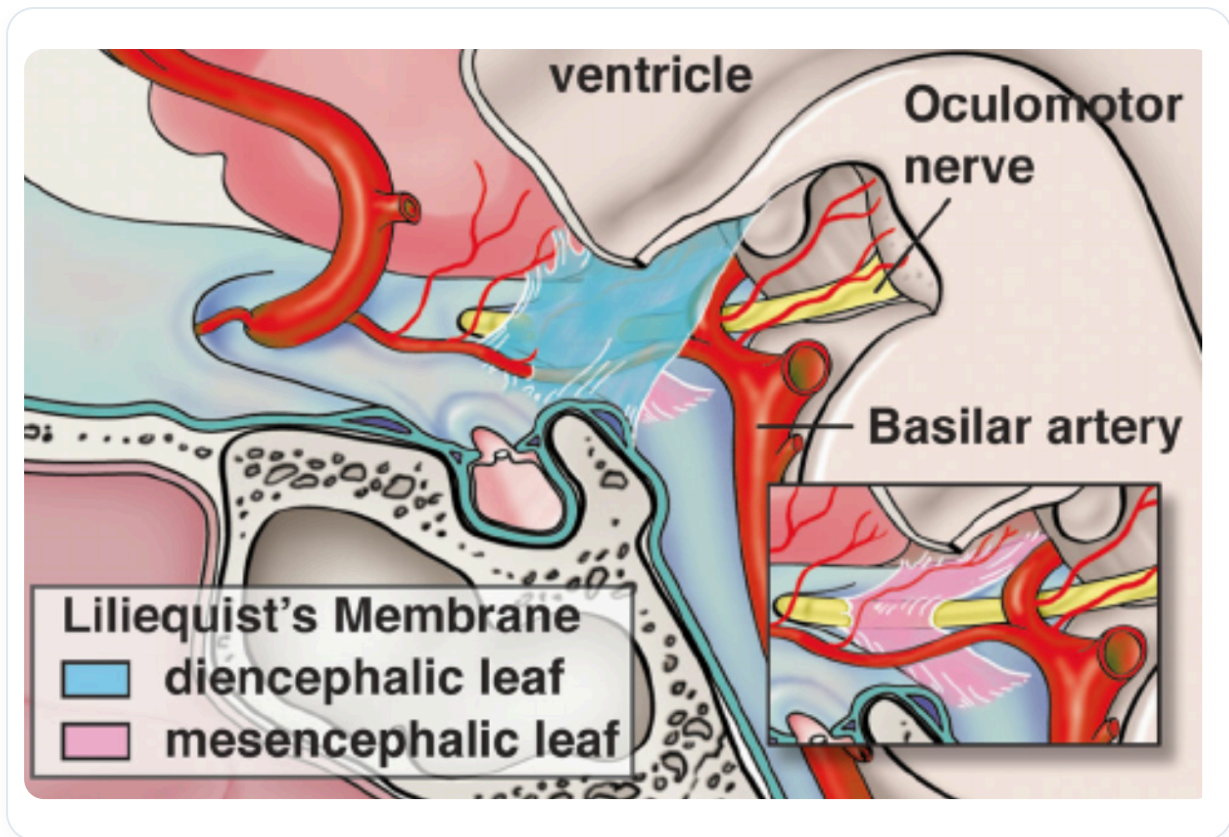


FIG. — Ligamento de Liliequist

Cuando el ligamento desciende, crea un **eje de tensión** que influye en el **sistema ventricular**. El tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, así como los **ventrículos laterales** están todos interconectados por esta dinámica. Se establece un esquema de tensión que tiene un impacto significativo en el espacio donde se encuentra la **hipófisis**.

Por encima de la hipófisis se encuentra el **quiasma óptico**, que está orientado a unos 30 grados, con un movimiento postural de 5 grados. Este movimiento es esencial para el **drenaje** entre el tercer ventrículo, el esfenoides y los **microvasos** circundantes. Los **pericitos**, presentes en los microcapilares, interactúan con los nervios, creando **espacios hematoencefálicos** que actúan como un punto de apoyo profundo.

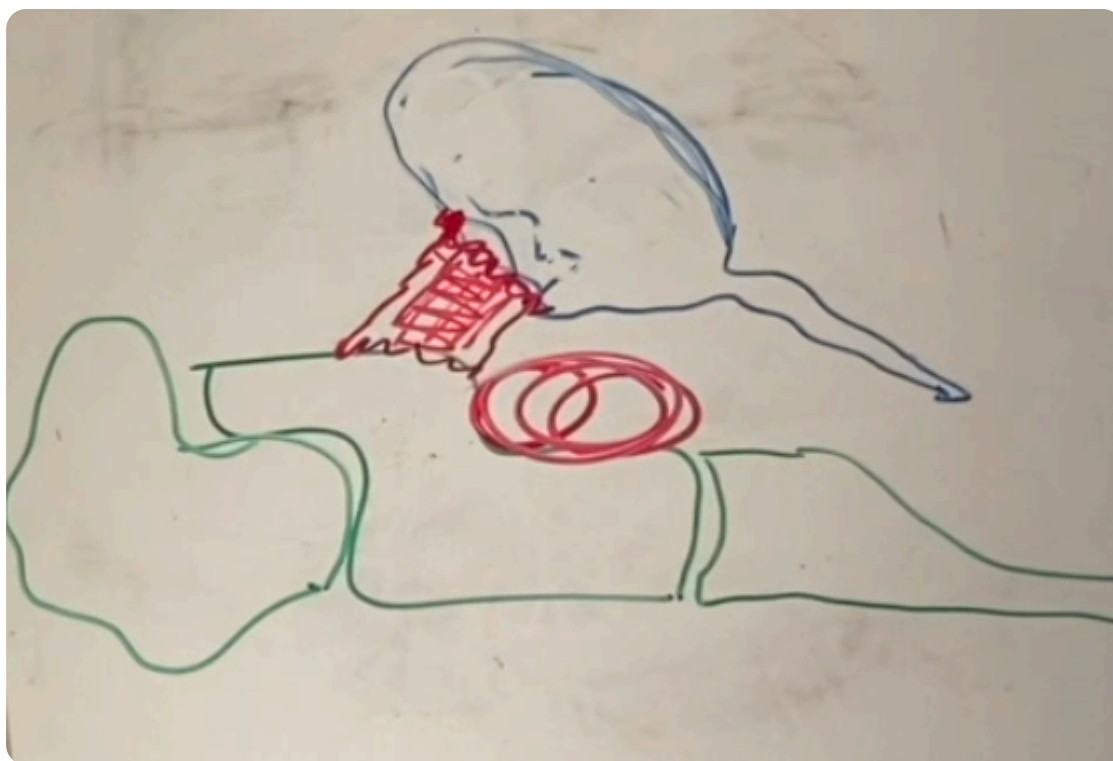


FIG. — Sistema ventricular

Al examinar los **preesfenoides**, que corresponden al **occipital**, se observa un espacio de balance en la membrana de Liliequist. Esta tensión membranosa afecta tanto a los nervios como a los vasos sanguíneos, y se sitúa cerca de la hipófisis, donde el sistema nervioso se comunica con el sistema hormonal a través del **eje hipotálamo-hipófisis-tiroides-suprarrenal-gonadal**.

El movimiento craneal también es importante a considerar. Al observar un cráneo, se pueden notar los diferentes movimientos a nivel de los **parietales** y otras estructuras. Estos movimientos siguen líneas de fuerza específicas. Por ejemplo, el movimiento de **flexión** a nivel frontal, asociado a la **sutura metópica**, representa dos puntos de balance que influyen en el movimiento del ojo.

Es crucial comprender que el **cerebro** condiciona el **sistema ventricular** y el **sistema facial**, tanto a nivel del **condrocráneo** (cartílago) como del **desmocráneo** (membrana). Durante el desarrollo, cuando el **occipital** desciende, el **sacro** también desciende, y los **temporales** juegan un papel clave en esta dinámica.

El **esternón** asciende en respuesta a estos movimientos, convergiendo hacia la línea media anterior. Todo esto está inscrito en el ojo, y es esencial añadir elementos concernientes al sistema facial y al sistema capsular del ojo, que se insertan alrededor y organizan el conjunto con una contrarrotación a nivel del desarrollo de la órbita.

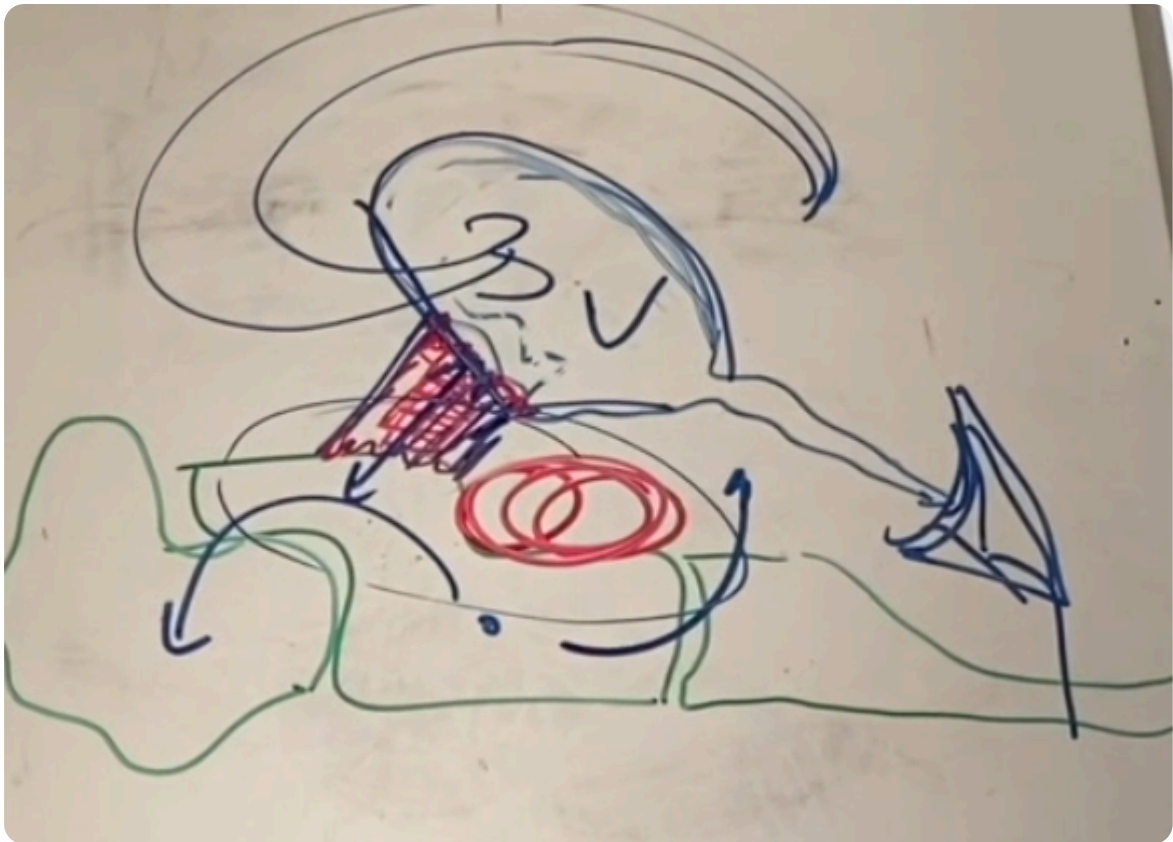


FIG. — *Movimientos craneales*

Los movimientos craneo-esterno-sacros y mandibulares están interconectados. Los ejes caninos también son importantes, ya que influyen en la **oclusión**. Si el encuentro canino superior e inferior no es correcto, esto conlleva una pérdida de información a nivel del cerebro, ya que estos campos eléctricos deben unirse.

La **oclusión** es, por lo tanto, el reflejo de las tensiones presentes en la **sínfisis esfenobasilar**. Al observar los dientes, es posible determinar la presencia de **strain** (tensión), ya sea vertical, lateral o de otro tipo. Esto permite comprender las restricciones y ajustar los tratamientos necesarios para restablecer el equilibrio.

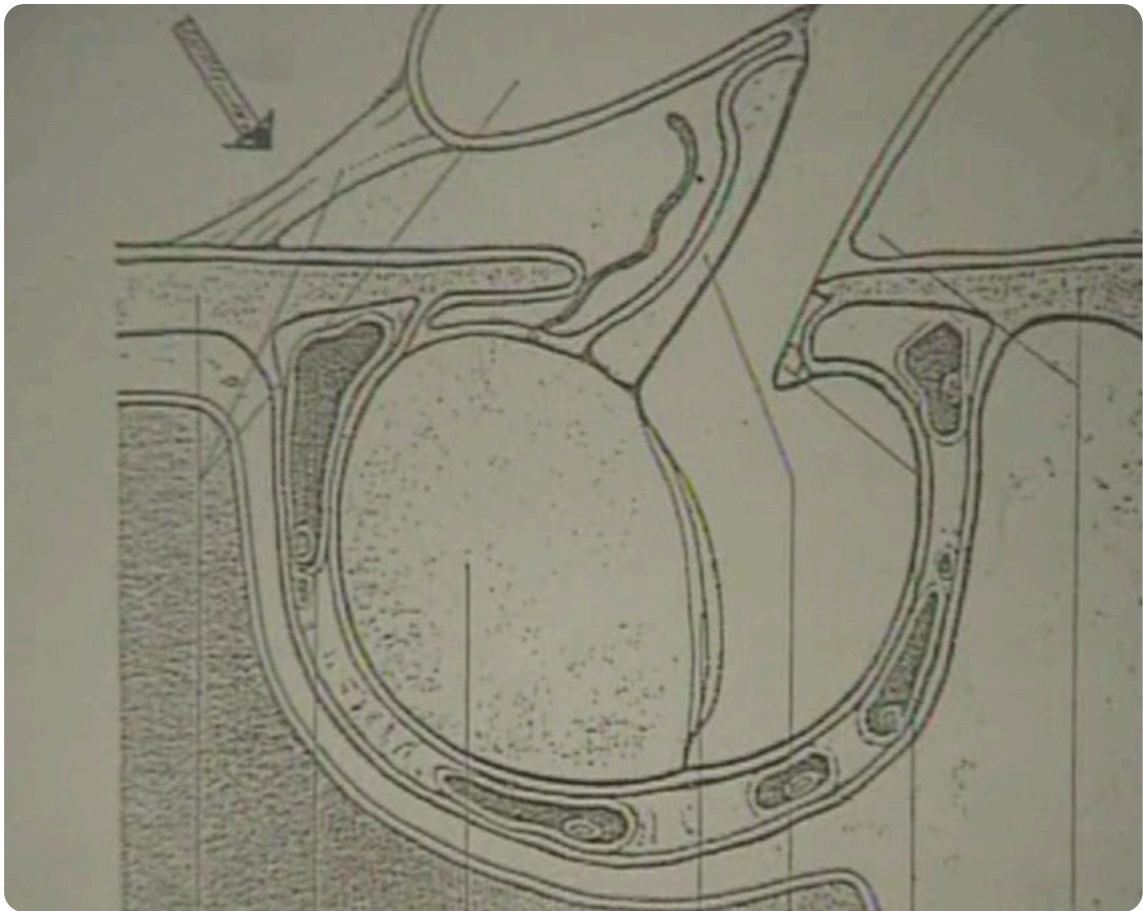


FIG. — *Movimientos coordinados del cráneo, esternón y sacro*